Клинические рекомендации

Простой герпес у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B00.1** — Герпетический везикулярный дерматит **B00.2** — Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит **B00.3** — Герпетический менингит (G02.0*) **B00.4** — Герпетический энцефалит (G05.1*) **B00.7** — Диссеминированная герпетическая болезнь **B00.8** — Другие формы герпетических инфекций **B00.9** — Герпетическая инфекция неуточненная **B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная **K12.1** — Другие формы стоматита
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 27.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ); Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/492_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика **5**

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Физикальное обследование 5

3.4 Лабораторные исследования 5

3.5 Инструментальные исследования 6

3.6 Консультации специалистов 6

4. Лечение **6**

4.1 Противовирусная терапия 6

4.2 Местное и симптоматическое лечение 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации **7**

5.1 Профилактика 7
5.2 Показания к госпитализации 8
6. Источник и актуальность **8**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Простой герпес — широко распространённая вирусная инфекция, вызываемая вирусами простого герпеса 1 и 2 типов: от бессимптомного течения и поражения кожи и слизистых оболочек до тяжёлых генерализованных форм с поражением ЦНС, внутренних органов, глаз.
- При типичной манифестной локализованной форме диагноз устанавливается по клинической картине. Методом выбора лабораторного подтверждения является ПЦР соскоба с высыпаний или содержимого везикул.
- **Противовирусная терапия внутрь (эпизодическая)**
  1. первичный эпизод: ацикловир 200 мг 5 раз в сутки, валацикловир 500 мг 2 раза в сутки или #фамцикловир 250 мг 3 раза в сутки, **7–10 дней**;
  2. рецидив: те же препараты в тех же дозах, **5 дней**.

  Лечение начинают при первых признаках поражения (зуд, жжение, покраснение), при рецидиве — желательно в продромальном периоде.
- **Оториноларингологу**
  1. характерная повторяющаяся локализация высыпаний — красная кайма губ, кожа вокруг рта, крылья носа, полость рта;
  2. при частых рецидивах в анамнезе перед манипуляциями, нарушающими целостность кожи и слизистых оболочек, показана превентивная противовирусная терапия **в течение 10 дней**;
  3. герпетический стоматит сопровождается болезненными эрозиями полости рта и регионарным лимфаденитом.
- Лёгкие, среднетяжёлые и неосложнённые формы лечат амбулаторно; тяжёлые, осложнённые и диссеминированные формы подлежат госпитализации в инфекционное отделение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Простой герпес (ПГ) — широко распространённая вирусная инфекция, вызываемая вирусами простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов, характеризующаяся многообразными проявлениями: от бессимптомного течения или поражения кожи и слизистых разной локализации до тяжёлых генерализованных форм с поражением центральной нервной системы, внутренних органов, глаз.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудителем является вирус простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-1 и ВПГ-2) семейства Orthoherpesviridae; геном представлен двуспиральной ДНК. Биологические свойства вируса — пантропизм, способность к пожизненной персистенции и латенции в организме человека.

ПГ является антропонозным заболеванием; в большинстве случаев инфицирование происходит в детском возрасте. Основные пути передачи — воздушно-капельный и контактно-бытовой, возможна аутоинокуляция. Входные ворота — кожа губ, слизистая оболочка полости рта, реже носоглотки, конъюнктива; риск заражения повышается при травматизации кожи и слизистых оболочек.

2.3 Классификация

Типичные формы по клиническим проявлениям и локализации

1. поражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта: стоматит, гингивит, эзофагит;
2. поражение кожи: герпес губ, крыльев носа, лица, рук, ягодиц;
3. поражение половых органов и урогенитального тракта;
4. поражение глаз (офтальмогерпес);
5. поражение нервной системы: менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, неврит, поражение бульбарных нервов;
6. поражение внутренних органов, генерализованный ПГ.

Атипичные формы: абортивная, отёчная, зостериформная, язвенно-некротическая, геморрагическая, эрозивно-язвенная и др.

Степень тяжести

1. лёгкая — **1–3 рецидива в год**;
2. средней тяжести — **4–6 рецидивов в год**;
3. тяжёлая — **6 и более рецидивов в год**.

2.4 Клиническая картина

Первичный ПГ возникает после первого контакта с вирусом, чаще в детском возрасте; характеризуется выраженной симптоматикой и может сопровождаться стадией предвестников.

Жалобы

1. жжение, покалывание, боль в области высыпаний;
2. усталость, слабость, недомогание, головная боль, нарушение сна, парестезии;
3. повышение температуры тела, болезненность и увеличение регионарных лимфатических узлов.

Продолжительность первичного эпизода — **10–14 и более дней**, рецидива — в среднем **5–6 дней**.

Рецидивирующий ПГ отличается меньшей интенсивностью и продолжительностью проявлений; частота рецидивов — от 1–3 до 6–12 и более в год. Высыпания фиксированы на месте внедрения вируса («locus minoris»), им предшествуют жжение, покалывание, зуд.

Элементы высыпаний

1. сгруппированные пузырьки 1,5–2 мм на фоне эритемы, содержимое мутнеет, иногда становится геморрагическим;
2. после вскрытия — болезненные эрозии с фестончатыми очертаниями и гиперемированным основанием;
3. регионарный лимфаденит с умеренно болезненными лимфатическими узлами;
4. после эпителизации — медленно разрешающаяся гиперпигментация.

Герпетический стоматит — поражение слизистой оболочки полости рта с пузырьковыми высыпаниями и эрозиями, повышением температуры тела и головной болью. Инкубационный период — **1–8 дней**.

1. высыпания на языке, внутренней поверхности губ, дёснах, щеках, твёрдом и мягком нёбе;
2. болезненные полициклические эрозии, гингивит с кровоточивостью дёсен, обильная вязкая саливация;
3. подчелюстные лимфатические узлы увеличены и болезненны, при среднетяжёлой и тяжёлой форме — двусторонний подчелюстной и шейный лимфаденит;
4. жалобы на боль при приёме пищи и неприятный запах изо рта.

При герпетическом везикулярном дерматите хроническое рецидивирующее поражение захватывает любой участок кожи и слизистых оболочек вне генитальной локализации: мелкие сгруппированные пузырьки на гиперемированном отёчном основании, после вскрытия — эрозии с полициклическими краями; возможны зуд, жжение, боль.

Герпетический энцефалит

1. начинается остро с высокой температуры, слабости, головной боли, тошноты и рвоты, респираторных симптомов;
2. нарушение сознания по типу спутанности, оглушённости, дезориентации у большинства больных, у 12% — до комы;
3. в 95% случаев возбудителем является ВПГ-1.

У нелеченых пациентов энцефалит быстро прогрессирует с отёком мозга и приводит к смерти **в течение 7–14 дней**; без своевременного противовирусного лечения летальность может превышать 50%.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

У пациентов с типичной манифестной локализованной формой ПГ диагноз устанавливается на основании клинической картины.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. эпизоды высыпаний с повторяющейся локализацией: красная кайма губ, кожа вокруг рта, крылья носа, полость рта, кисти;
2. зуд, жжение, покалывание, боль в области высыпаний;
3. симптомы интоксикации и подъём температуры;
4. болезненность и увеличение регионарных лимфатических узлов.

3.3 Физикальное обследование

При осмотре оценивают

1. общее состояние и системные проявления;
2. цвет, влажность и отёчность кожи и видимых слизистых оболочек;
3. характер высыпаний — везикулы, эрозии, язвы, их локализацию, величину и глубину;
4. болезненность и интенсивность слюноотделения при поражении полости рта.

Всем пациентам выполняются осмотр и пальпация лимфатических узлов головы, шеи и паховой области с определением их болезненности и размеров.

3.4 Лабораторные исследования

Лабораторное подтверждение необходимо

1. при атипичных, стёртых, торпидных и бессимптомных формах, в том числе при иммуносупрессии;
2. для дифференциальной диагностики;
3. для изменения тактики лечения.

Выявление ДНК ВПГ-1/-2 методом ПЦР в соскобах со слизистой оболочки полости рта, в отделяемом везикул и эрозивно-язвенных поражений кожи является методом выбора.

Наибольшее диагностическое значение имеет выявление IgM к ВПГ-1/-2 — признак острого заболевания, реинфекции или реактивации; при типичном течении IgM выявляются редко (3–6%). Лабораторным критерием, подтверждающим диагноз, является нарастание титра IgG **в 4 и более раз** за 10–14 дней (метод парных сывороток).

При неврологической симптоматике ПЦР спинномозговой жидкости является «золотым» стандартом диагностики герпетического энцефалита и менингита (чувствительность 98%, специфичность 100%). При отрицательном результате и сохраняющихся клинических или нейровизуализационных признаках исследование повторяют **через 3–7 дней**.

3.5 Инструментальные исследования

При частоте рецидивов **не более 2 раз в год** и типичной локализованной форме инструментальные исследования не рекомендуются.

При тяжёлом, диссеминированном течении или поражении ЦНС выполняются спинномозговая пункция и КТ или МРТ головного мозга. Противопоказаниями к люмбальной пункции являются прогрессирующий отёк головного мозга, дислокационный синдром, геморрагический синдром; при повышенном внутричерепном давлении ацикловир начинают до пункции.

При энцефалите очаги некроза чаще выявляются в лобно-височной области **с 5–7-го дня** заболевания; нейровизуализация не достаточна для этиологического диагноза.

3.6 Консультации специалистов

1. **невролог** — при поражении ЦНС, коморбидной патологии, торпидности терапии
2. **офтальмолог** — при поражении органов зрения, для оценки внутричерепной гипертензии
3. **стоматолог-терапевт** — при патологии полости рта
4. **аллерголог-иммунолог** — при частоте рецидивов **более 6 раз в год**
5. **анестезиолог-реаниматолог** — при жизнеугрожающих состояниях, прогрессировании общемозговой и очаговой симптоматики

При часто рецидивирующем ПГ, в том числе с язвенно-некротическими проявлениями, устойчивом к терапии, и при энцефалите показано обследование на ВИЧ-инфекцию: ПГ рассматривается как СПИД-индикаторное заболевание.

---

4. Лечение

4.1 Противовирусная терапия

Пациентам с первичным эпизодом или рецидивом ПГ назначаются противовирусные препараты системного действия; терапию начинают на ранних сроках, до получения результатов вирусологического исследования, эмпирически.

Препараты группы нуклеозидов и нуклеотидов начинают при первых признаках поражения кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение, покраснение); при рецидивирующем герпесе — желательно в продромальном периоде или в самом начале рецидива.

Первичный клинический эпизод — внутрь

1. ацикловир: 200 мг 5 раз в сутки, **7–10 дней**;
2. валацикловир: 500 мг 2 раза в сутки, **7–10 дней**;
3. #фамцикловир: 250 мг 3 раза в сутки, **7–10 дней**.

Рецидив — внутрь

1. ацикловир: 200 мг 5 раз в сутки, **5 дней**;
2. валацикловир: 500 мг 2 раза в сутки, **5 дней**;
3. фамцикловир: 250 мг 3 раза в сутки, **5 дней**.

При тяжёлом или диссеминированном течении, поражении ЦНС, судорогах или поражении внутренних органов назначается ацикловир внутривенно — медленной инфузией **в течение 1 часа**.

1. ВПГ-инфекция, кроме энцефалита: 5 мг/кг каждые 8 часов, как правило, **5 дней**; при тяжёлых инфекциях — 5–10 мг/кг каждые 8 часов до разрешения или **до 14–21 дня** с переходом на приём внутрь;
1. герпетический энцефалит: 10 мг/кг каждые 8 часов **14 дней**, в ряде случаев **до 21 дня**; доза снижается при почечной недостаточности.

Супрессивная терапия
Показана при рецидивах **более 6 раз в год**, «монотонном» или тяжёлом течении, низкой эффективности эпизодической терапии.

1. #ацикловир: 400 мг 2 раза в сутки;
2. валацикловир: 500 мг 1 или 2 раза в сутки; при 10 и более рецидивах в год — 1 г в сутки;
3. фамцикловир: 250 мг 2 раза в сутки.

Перед супрессивной терапией необходимо ПЦР-подтверждение ВПГ-инфекции; после курса делают перерыв для оценки течения. Эффективность оценивают как минимум по двум рецидивам.

При часто рецидивирующем ПГ в анамнезе после манипуляций, нарушающих целостность кожи и слизистых оболочек или связанных с воздействием на чувствительные нервные волокна, проводится превентивная терапия **в течение 10 дней**.

1. #ацикловир: 200 мг 5 раз в сутки;
2. валацикловир: 500 мг 1 раз в сутки;
3. фамцикловир: 250 мг 2 раза в сутки.

При низкой эффективности противовирусных препаратов или противопоказаниях к ним в комплексной терапии рецидивирующего и осложнённого ПГ применяют препараты интерферонов.

4.2 Местное и симптоматическое лечение

Местная терапия дополняет, но не заменяет системную противовирусную.

1. противовирусные мази и кремы, например ацикловир, мазь 5%;
2. антисептики — для профилактики вторичной инфекции;
3. при стоматите — полоскания, протеолитические ферменты, препараты для заживления раневой поверхности.

1. **лихорадка выше 38,0 °C** — производные пропионовой кислоты, анилиды, производные уксусной кислоты
2. **боль при поражении полости рта** — местное обезболивание перед едой, например лидокаин, гель 2%
3. **зуд, жжение, аллергическая реакция** — антигистаминные средства системного действия: хлоропирамин 75–100 мг в сутки, курс **до 5 дней**

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

У пациентов с рецидивирующим ПГ выявляют факторы риска частого рецидивирования.

При часто рецидивирующем (**более 6 раз в год**), тяжёлом или «монотонном» течении, низкой эффективности или противопоказаниях к супрессивной терапии проводится специфическая иммунная терапия вакциной для профилактики герпетических инфекций — только в стадии ремиссии, **не ранее чем через 10 дней** после исчезновения проявлений.

Курс при поражении кожи и слизистых оболочек — 5 внутрикожных инъекций по 0,2 мл с интервалом 7 дней.

Пациенты, перенёсшие тяжёлые и осложнённые формы ПГ или ПГ с поражением нервной системы, после выписки подлежат диспансерному наблюдению.

5.2 Показания к госпитализации

Лёгкие, среднетяжёлые и неосложнённые формы ПГ лечат в амбулаторных условиях; при безуспешности лечения или невозможности его проведения рассматривается госпитализация.

Показания к госпитализации

1. тяжёлая форма ПГ;
2. осложнённая форма;
3. диссеминированная форма.

Тактику ведения пересматривают

1. при новых высыпаниях или признаках генерализации;
2. при осложнениях со стороны ЦНС: изменение психического состояния, сонливость, судороги, спутанность сознания, паралич;
3. при вторичной бактериальной инфекции, в том числе высокой температуре **более 3 дней**.

Критерии выписки

1. улучшение клинической картины;
2. отсутствие угрозы жизни и здоровью пациента.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Простой герпес (ПГ) у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 16.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	492_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского; Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Классификация по тяжести (раздел 1.5.7) относит 6 рецидивов в год одновременно к средней («4–6») и тяжёлой («6 и более») степени, тогда как показания к супрессивной терапии, вакцинации и консультации иммунолога сформулированы как «более 6 раз в год».